**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**
Área de Salud de Guápiles
Dirección Medica
Teléfono: 2710-4552, extensión 26341005; nymarin@ccss.sa.cr
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

**ASG-DM-0343-2025**
09 de diciembre de 2025

A todo el personal
**AREA DE SALUD DE GUAPILES- 2634**

Estimados compañeros:

**ASUNTO: Resumen Fichas Técnicas 2024 - 2028. (Actualizado 09-12-2025)**

Reciban cordial saludo. Se les traslada resumen de Fichas Tecnicas 2024 -2028 para que sea utilizado como material de consulta durante la Prestacion de Servicios al Usuario:

## SALUD MATERNO INFANTIL:

### A. Porcentaje de recién nacidos con tamizaje neonatal oportuno.

Porcentaje de niños menores de 28 días de vida a quienes se les realiza una prueba del talón entre el 3 y 7 día de edad en el periodo.

### B. Porcentaje de muestras insatisfactorias para el tamizaje neonatal

Porcentaje de muestras tomadas con calidad insatisfactoria para el tamizaje neonatal.
Se espera alcanzar el 2%

### C. Tiempo de tránsito promedio de las muestras para tamizaje neonatal.

Tiempo de tránsito: se define como el tiempo en días, desde que se toma la muestra en el centro de salud hasta que es recibida en el Laboratorio Nacional de Tamizaje Neonatal y Alto Riesgo, donde se realiza los diferentes estudios relacionados con el tamizaje neonatal.
Se espera para el quinquenio una mejora en el registro, alcanzando los 2 días

### D. Cobertura de atención temprana de menores de un año. Código: Z001

Atención temprana de menores de un año: es la atención que se realiza en los **primeros 7 días** de vida.

| EDAD DE CITA | ACCIONES |
|---|---|
| **Captación primeros 7 días** | Anotar LM, pretest Denver, Enfasis |
| **Cita a los 2 meses** | Anotar LM, pretest Denver, Enfasis |
| **Cita a los 4 meses** | Anotar LM, pretest Denver, envió de Hemograma, iniciar hierro profiláctico 2m/kg Énfasis |
| **Cita a los 6 meses** | Anotar LM, pretest Denver, Énfasis, interpretación de laboratorio si esta normal envió de hierro profiláctico y si esta alterado iniciar programa de Anemia |
| **Cita a los 9 meses** | Anotar LM, pretest Denver, Énfasis, enviar hemograma para control anual |

## SALUD NIÑEZ Y ADOLESCENCIA:

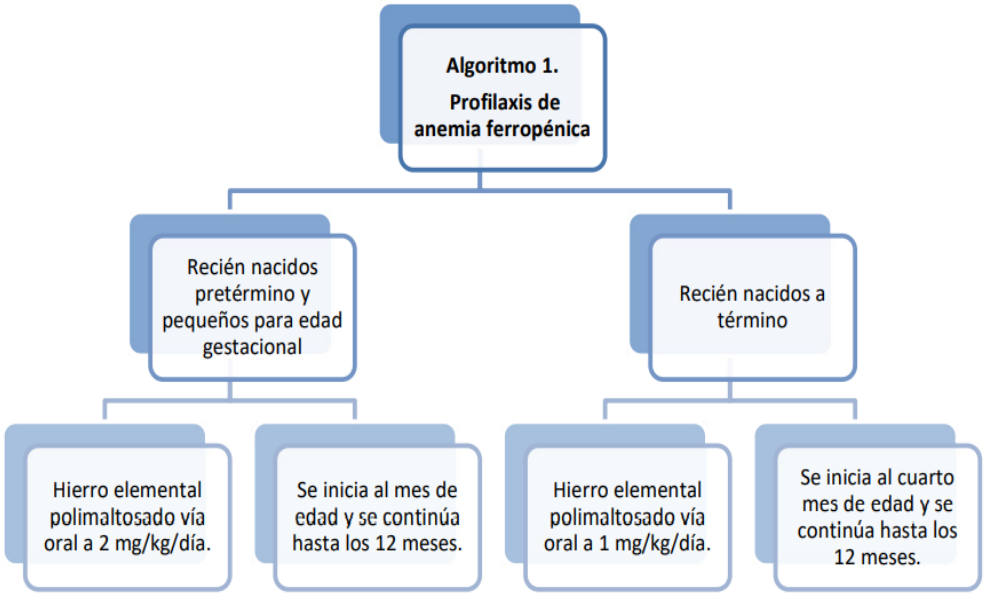
### "Anemia" fisiológica del lactante

Este término se refiere a la caída progresiva de la hemoglobina, que ocurre entre las semanas

- 3 y 6 semanas de vida de aquellos nacidos pretérmino **Código: Z001**
- 8 y 12 semanas de vida en niños y niñas nacidos a término y

Generalmente cursa con una hemoglobina de 9-11 mg/dl, presentando niveles más bajos en recién nacidos pretérmino.

**En general, este fenómeno es normal y no requiere tratamiento.**




**Fuente.** Elaboración propia.

## Anemia por deficiencia de hierro

La anemia se define con una concentración de hemoglobina con más de dos desviaciones estándar por debajo de la media para la edad y el sexo

**Tabla 1. Concentraciones de hemoglobina para diagnosticar anemia a nivel del mar y evaluar su gravedad en niños y niñas**

| POBLACIÓN | SIN ANEMIA | ANEMIA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Leve | Moderada | Grave |
| 6 meses a menos de 5 años | 11 g/dl o superior | 10 a 10.9 g/dl | 7 a 9.9 g/dl | Menos de 7 g/dl |
| 5 a menos de 12 años | 11.5 g/dl o superior | 11 a 11.4 g/dl | 8 a 10.9 g/dl | Menos de 8 g/dl |
| 12 a menos de 14 años | 12 g/dl o superior | 11 a 11.9 g/dl | 8 a 10.9 g/dl | Menos de 8 g/dl |

**Fuente.** Adaptado de Organización Mundial de la Salud. (2011)[12].

**A. Tamizaje oportuno para la anemia por deficiencia de hierro de la población de seis a menos de 10 meses.**

Tamizaje **oportuno** de anemia:
Realización de una hemoglobina entre los **5 meses 21 días y los 9 meses 29 días** de edad.

Tamizaje tardío de anemia:
Realización de una hemoglobina entre los **10 meses y los 12 meses días** de edad.

Tamizaje anual de anemia:
Realización de una hemoglobina **entre 1 año a los 12 años** se realizará un hemograma por año (considerar solicitud de hemograma completo con ocasión de cualquier consulta del niño o la niña aprovechando todos los contactos con el servicio de salud tanto realizados en los SEM o en escenario escolar, no se deben repetir).

**B. Porcentaje de la población infantil de seis a menos de 24 meses con anemia por deficiencia de hierro resuelta Meta 43%.**

Porcentaje de la población infantil de 6 a menos de 24 meses con anemia por deficiencia de hierro resuelta.

Hemograma de control oportuno: Realización de una hemoglobina entre uno y cuatro meses posteriores al diagnóstico que tenga resolución de su anemia (entre los 30 y 149 días) a la fecha del diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro.

Resolución de la anemia: cuando en el hemograma de control realizado de forma oportuna se reporta un resultado de hemoglobina > 11g/dL.

**C. Porcentaje de niñas de 10 años con anemia por deficiencia de hierro resuelta. Meta 53%**

Hemograma de control oportuno: Realización de una hemoglobina entre uno y cuatro meses posteriores al diagnóstico que tenga resolución de su anemia (entre los 30 y 149 días) a la fecha del diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro.
Resolución de la anemia: cuando en el hemograma de control realizado de forma oportuna se reporta un resultado de hemoglobina > 11.5 g/dL.

**La anemia se aborda según el grado de anemia de la siguiente manera**

Administrar terapia oral con hierro vía oral a dosis de **6 mg/kg/día (independiente de la severidad de la anemia).**

**Anemia leve** (Hemoglobina 10 a 10.9 g/dl en menores de 5 años, 11 a 11.4 g/dl en mayores de 5 años con el resto del hemograma normal).
**Código D509 anemia por deficiencia de hierro.**

1. Prescribir hierro 6 mg/kilo por 4 meses ininterrumpidos.
2. Realizar hemograma a los 4 meses del diagnóstico, o sea al final del tratamiento entre 120 y 149 días).
3. Cita programada con hemograma control después de los 4 meses es decir entre los 121 días y 149 días después del diagnóstico. (Primer y única cita de control de anemia)
4. Si la hemoglobina no se normaliza debe realizarse una valoración integral descartando problemas de adherencia al tratamiento.
5. Si se estable que la adherencia al tratamiento fue adecuada, referir a Pediatría con prioridad solicitando exámenes de laboratorio control que deben incluir hemograma completo con reticulocitos, morfología de glóbulos rojos, heces por parásitos (#3 seriados), sangre oculta en heces y examen general de orina.

**Anemia moderada** (Hemoglobina 7 a 9.9 g/dl en menores de 5 años, hemoglobina 8 a 10.9 g/dl en mayores de 5 años con el resto del hemograma normal)
**Código D509 anemia por deficiencia de hierro.**

1. Realizar un control de hemograma después de 1 mes (31 días después del diagnóstico) con de terapia oral a dosis terapéutica (6 mg/kg/ día)
2. Cita en el EBAIS con resultado de laboratorio para valorar prueba terapéutica (1 cita de control de anemia)

**Si la prueba terapéutica es positiva**, **aumento de 1g /dl o alcanzar su nivel normal según edad.**

1. Continuar con hierro a dosis terapéutica hasta alcanzar los niveles normales de hemoglobina según la edad y a partir este momento se debe completar el tratamiento con 3 meses más de hierro oral a dosis terapéutica para llenar depósitos.
2. Laboratorio control se realizará 3 meses posterior a esta segunda cita debe estar entre 90 y 149 días.
3. Cita programada con hemograma control después de los 3 meses es decir entre los 91 días y 149 días (2 cita de control de anemia).
4. Si en esta si la evolución es satisfactoria (nivel de hemoglobina normal según edad)
    a. Se indica hierro a dosis terapéuticas por 4 meses más.
    b. Cita con hemograma control, después de 4 meses.
5. Si la anemia es persistente en un tiempo máximo de 4 meses de realizado el diagnóstico, se indica remitir a Pediatría con los exámenes de laboratorio hemograma completo con reticulocitos, morfología de glóbulos rojos, heces por parásitos (#3 seriados), sangre oculta en heces y examen general de orina.

**Si la prueba terapéutica es negativa, aumento menor 1g /dl o no llegar valor normal de hemoglobina según su edad.**

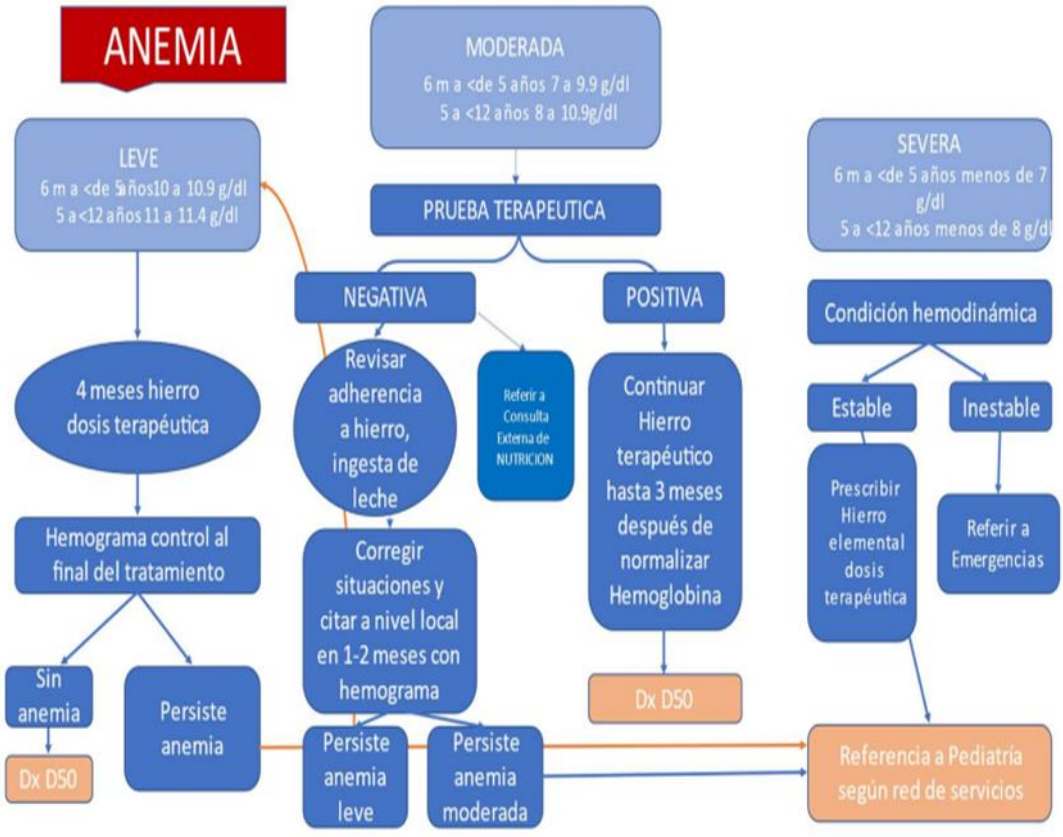
1. Comprobar la adherencia a la prescripción del hierro suplementario según indicación médica (la adherencia inadecuada al tratamiento es la causa más común de falta de respuesta) y verificar la dosis de hierro por kilogramo de peso que está recibiendo el niño o niña. Se debe además educar a la persona cuidadora para la aplicación de recomendación en la alimentación.
2. Referir a consulta externa de Nutrición de manera prioritaria.
3. Si se confirma problemas en la adherencia al tratamiento y/o en la alimentación continuar con hierro a dosis terapéutica por 1 o 2 meses y programar consulta de seguimiento para revisión de hemograma de control.
    a. Si se logra una prueba terapéutica positiva, se procede como indicado en apartado anterior (ejemplo de tratamiento anemia moderada con prueba positiva).
4. Si no se identifica problemas de adherencia al tratamiento ni de alimentación, referir a Pediatría de manera, manteniendo el hierro a dosis terapéutica.
    a. El profesional de pediatría debe tener acceso a exámenes de laboratorio recientes (tomados en lapso de 1 mes antes de la cita) entre los cuales se

incluirá hemograma completo con reticulocitos, morfología de glóbulos rojos, heces por parásitos (#3 seriados), sangre oculta en heces y examen general de orina.

**Anemia severa (hemoglobina menor de 7 g/dl en menores de 5 años, menor de 8 g/dl en mayores de 5 años con el resto del hemograma normal) Código D509 anemia por deficiencia de hierro.**

1. Si el niño o la niña se encuentra hemodinámicamente estable, indicar hierro elemental a dosis terapéutica (6 mg/ Kg/día) por 1 mes y referir a Pediatría con prioridad.
2. Si el niño o la niña se encuentra hemodinámicamente inestable referir al Servicio de Emergencias.

Algoritmo 2. Abordaje anemia




**Fuente.** Elaboración propia.

## SALUD MATERNO INFANTIL:

**A. Cobertura de atención temprana de mujeres en periodo posnatal. Códigos:**
**Z390. Atención y examen inmediatamente después del parto,**
**O03. Aborto espontaneo**

Atención temprana de mujeres en periodo posnatal o postaborto: es la atención que se realiza en los primeros **7 días** del parto.
Se debe registrar una fecha de parto en el apartado "posparto ítem captación temprana" y la consulta de primera vez.

**B. Cobertura de atención temprana de embarazadas.**
**Códigos:**
**Z321. Embarazo confirmado,**
**Z35. Supervisión de embarazo de alto riesgo**

Atención temprana de embarazadas: es la atención que se realiza en las **primeras 11 semanas** de gestación.

**C. Porcentaje de embarazadas a quienes se les completa el paquete básico de intervenciones según edad gestacional.**

| INTERVENCIONES DEL PAQUETE BÁSICO SEGÚN RANGO DE EDAD GESTACIONAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 a 11 semanas** | **12 a 19 semanas** | **20 a 28 semanas** | **29 a 32 semanas** | **33 a 40 semanas** | **41 a 42 semanas** |
| **Captación Laboratorios Hemograma, Glicemia ayunas VDRL, HIV, Grupo y RH, EGO, Hepatitis B.**<br><br>**Envió de Ultrasonido**<br><br>**Referencia a Odontología** | **Detección HIV y VDRL** | **2 VDRL**<br><br>**Detección DM gestacional 24 a 28 semanas Curva de 75 gramos** | | **3 VDRL**<br><br>**Tamizaje Agalactiae entre las 35 y 37,6 semanas** | |
| **Detección de VIH 19 sem** | | | | | |
| **Detección de Sífilis 19 sem** | | | | | |
| **Detección de DM pregestacional hasta 23 semanas** | | | | | |
| **Entrega Kit de Zika hasta 24 semanas** | | | | | |
| **Toma de presión arterial todas las citas** | | | | | |
| **EGO todas las citas** | | | | | |

**D. Porcentaje de embarazadas seropositivas para sífilis que reciben tratamiento oportuno y adecuado. Código: O981 Sífilis que complica el embarazo, parto y puerperio.**

Embarazadas seropositivas para sífilis: mujeres desde el momento de la concepción hasta las 42 semanas de gestación con una prueba de laboratorio clínico de serología VDRL positiva o reactiva (independientemente de las titulaciones).

Tratamiento oportuno y adecuado: administración por vía intramuscular de 2,4 millones penicilina g benzatínica en los primeros 10 días hábiles a partir de la fecha de ingreso del reporte de la serología VDRL positivo, según sea el caso.

1. La Auxiliar de Enfermería debe de registrar en el Expediente la aplicación de cada dosis, con la fecha.
2. Después de iniciado el Tratamiento este no debe de ser suspendido, ni aunque se reciba un resultado de FTA negativo.
3. Si el VDRL control post tratamiento muestra un aumento igual o mayor a 4 veces la titulación anterior se debe de volver a dar tratamiento y realizar estudio de LCR, por lo que paciente se debe de referir a ARO.
4. No aplicación de la Penicilina benzatínica cuando la titulación se mantiene o disminuye.
5. Se debe citar y tratar a la o las parejas sexuales.
6. Educación a la usuaria y su pareja sobre: Relaciones sexuales saludables, uso de condón, toma de tratamiento, importancia de realizar los laboratorios y asistir a las consultas médicas programadas.
7. Confeccionar boleta VE-01, con copia.
8. Si la paciente no llega antes de los 10 días entre cada dosis, se debe de reiniciar el tratamiento.
9. Tratamiento adecuado: aplicación de la penicilina G benzatínica por vía intramuscular, según sea el caso
10. Seguimiento del caso: realización de serología VDRL control entre los dos y tres meses (61 y 119 días) posterior a la consulta del manejo del caso.

**INTERVENCIÓN – PREVENCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ATEROESCLERÓTICA:**

**A. Porcentaje de población de 9 a 11 años con tamizaje universal de Dislipidemia**

Tamizaje universal de Dislipidemia:

**Realización** de al menos un perfil de lípidos completo entre los 9 y 11 años, independientemente de los factores de riesgo cardiovasculares.

Perfil de lípidos completo: Perfil de lípidos cuyos componentes (Colesterol total, Colesterol HDL y Triglicéridos) cuentan con resultados realizados en la misma fecha.

Primera consulta en el periodo de la población de 9 a 11 años en la que se registre tanto el **peso como la talla**, ambos necesarios para el indicador complementario de estado nutricional.

Excluye: Población entre los 9 y 11 años tamizados por dislipidemia en años anteriores.
Indicador complementario:

Porcentaje de la población de nueve a 11 años tamizados con componentes del resultado del perfil en alto riesgo según clasificación del estado nutricional (sin clasificación, desnutrición, normal, sobrepeso, obesidad), con el fin de analizar su relación de riesgo.

Línea base: Desnutrición/Normal: 34 % y Sobrepeso/Obesidad: 60 %

**B. Porcentaje de población de 2 a 19 años con obesidad a quienes se les tamiza por Dislipidemia. Mea 69%**

Consultas de la población de 2 a 19 años (19 años, 11meses y 29 días) con obesidad atendidos en el periodo evaluado

Para establecer los casos con obesidad se emplea la primera consulta del año en la que se registre tanto el dato del **peso como el de la talla.**

Pruebas de laboratorio clínico (perfiles de lípidos) realizadas en el periodo en el rango de edad, que tengan fecha de toma de la muestra y resultado.

Indicador complementario:

**Porcentaje de población de dos a 19 años con clasificación del estado nutricional, según las siguientes categorías: a) Sin clasificación b) Desnutrición c) Normal d) Sobre peso e) Obesidad.**

Línea base 03-04-1.0: 93 % y 03-05-1.1: 94 %

**C. Porcentaje de la población de 2 a 19 años con tamizaje de dislipidemia y que tienen al menos un componente del perfil de lípidos en alto riesgo.**

Porcentaje de la población de dos a 19 años con tamizaje de dislipidemia y que tienen al menos un componente del perfil de lípidos en alto riesgo.

La clasificación de los componentes del perfil de lípidos según el riesgo se establece utilizando la información que se encuentra en el Manual de

Procedimientos de Atención Integral al Niño y la Niña en el Primer Nivel de Atención, y definen los siguientes rangos: pág. 176 en adelante

| Componentes del perfil lipídico | Normal | Límite superior | Alto riesgo |
|---|---|---|---|
| Colesterol total | <170 | 170-199 | ≥200 |
| LDL-colesterol | <110 | 110-129 | ≥130 |
| HDL-colesterol >45 40-45 <40 | >45 | 40-45 | <40 |
| Triglicéridos menores de 10 años | <75 | 75-99 | ≥100 |
| Triglicéridos edad de 10-19 años | <90 | 90-129 | ≥130 |

## SALUD DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR:

**A. Cobertura de personas de 65 años y más atendidas bajo el énfasis de adulto mayor.**
**Código z138**

Corresponde al porcentaje de personas de 65 años y más que fueron atendidos a quienes se les aplicó el énfasis de Adulto Mayor completo, contenido en EDUS-SIES.

• Consultas de primera vez de personas de 65 años y más, en las áreas de salud del primer nivel durante periodo.

Se debe cumplir durante la consulta con:

- Toma de PA en todas las consultas •
- Toma de frecuencia cardiaca en todas las consultas •

- **Valoración, clasificación y seguimiento del tamizaje de riesgo, con anotación de los factores de riesgo.**
- Anotación del Examen Físico
- Anotación y valoración de la agudeza visual y auditiva
- Revisión de la cavidad oral y/o referencia
- Realización y anotación del tacto rectal. Si paciente no desea realizárselo debe de quedar la anotación en el Expediente
- Envió e interpretación de Laboratorios: Hemograma, glicemia, perfil lipídico, EGO, Heces por parásitos y Guayaco, Antígeno prostático a los hombres.
- Prescripción de antiparasitarios
- Revisión y aplicación de vacunas de influenza y neumococo. Deben quedar anotadas en el EDUS

## ECNT: DIABETES MELLITUS TIPO 2:

Se debe cumplir durante la consulta con:

- Anotación del Examen Físico
- Anotación y valoración de revisión de cavidad oral o referencia a odontología
- Anotación y valoración del Fondo de Ojo
- Anotación y Valoración de la Wagner pie diabético
- Envió e interpretación de Laboratorios:
  - ✓ Hemograma, UN/ Creatinina, relación albumina creatinina, glicemia en cada consulta, perfil lipídico, EGO en cada consulta, HB glicosilada 1 por semestre.
- Envío e interpretación del EKG anual
- Anotación y valoración del daño a Órgano Blanco, debe quedar marcado en el énfasis si existe:
  - Cardiopatía
  - Nefropatía
  - Retinopatía
  - EAP
  - ECV

### A. Cobertura de atención de personas con diabetes mellitus tipo 2

Personas de 20 años y más con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que consultan por primera vez en el año según:

Grupos de edad (20 a 39, 40 a 64, y 65 años y más) y Sexo (Masculino y Femenino).

**B. Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control glicémico óptimo. Meta 52%.**

Control glicémico óptimo:

1. Valor de hemoglobina glicosilada (A1c) **inferior a 7 %** en la última medición del período, en la persona con diabetes mellitus tipo 2.
2. En el caso de las personas mayores de **80 años** se define un valor **inferior a 8 %.**

Indicador complementario:

**Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con realización de al menos una hemoglobina glicosilada en cada semestre**.

Línea base 67%.

Para el seguimiento anual se considera únicamente la medición hecha en el segundo semestre.

**C. Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control óptimo de la presión arterial. Meta 60%**

Control óptimo de presión arterial:

1. Cifras de presión arterial **menores a 130/80** mmHg en la persona con diabetes mellitus tipo 2, en la última consulta.

**D. Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control lipídico óptimo. Meta 45%**

Control óptimo de LDL:

1. Valor de colesterol-LDL menor a 100 mg/dL en la última medición del perfil lipídico en la persona con diabetes mellitus tipo 2 en el período.

Indicador complementario:

**Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con realización de al menos un perfil lipídico al año. Meta 87%.**

Indicador complementario:

**Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control óptimo en cada uno de los parámetros clínicos según edad y sexo. Línea Base.**

Indicador complementario:

**Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con metas alcanzadas de manera integral (glicémico, lipídico y presión arterial). Línea Base.**

Indicador complementario:

**Tasa de inercia terapéutica en diabetes mellitus tipo 2 para control glicémico no óptimo.**

La inercia terapéutica en el control glicémico de las personas con DM2 es una condición individual en la que, a pesar de demostrarse niveles no óptimos en un período determinado, no se realiza ningún ajuste en el tratamiento para controlar la hiperglicemia -dosis o tipo de medicamento- en al menos cuatro consultas de seguimiento realizadas en ese período.
Control glicémico no óptimo: resultado de hemoglobina glicosilada (A1c) ≥ 8 %, aplicable a cualquier edad.

Indicador Complementario:

**Tasa de inercia terapéutica en diabetes mellitus tipo 2 para control lipídico no óptimo**.

La inercia terapéutica en el control lipídico de las personas con DM2 es una condición en la que, a pesar de demostrarse niveles no óptimos de colesterol-LDL (≥ 100 mg/dL) en un período determinado, no se realiza ningún ajuste en el tratamiento hipolipemiante -dosis o tipo de medicamento- en al menos cuatro consultas de seguimiento realizadas en ese período.

## ECNT: HIPERTENSIÓN ARTERIAL:

### A. Cobertura de atención a personas con hipertensión arterial (HTA). Meta 52%

Corresponde al porcentaje de personas de 20 años y más atendidas por HT en relación con la cantidad de personas de 20 años y más con HT de la población, según el dato más reciente de prevalencia estimada, en el periodo.

Se calculará mediante ajuste indirecto por estructura poblacional, considerando: Sexo (hombres, mujeres). Grupos de edad (20–39, 40–64, 65 y más).

**B. Control óptimo de la presión arterial en personas con hipertensión arterial (HTA). META 56%**

Cifras óptimas de presión arterial: Valores menores a los límites superiores de presión arterial sistólica y diastólica (que han demostrado no aumentar el riesgo cardiovascular de las personas con HTA), según las guías de manejo de personas con esta patología.

| POBLACION | META |
|---|---|
| **Personas de 20 años y más, con Diabetes Mellitus ó Enfermedad Renal Crónica ó Cardiopatía Isquémica ó Alto riesgo cardiovascular** | **<130/< 80 (mmHg).** |
| **Personas de 20 a 84 años: con Bajo/Moderado riesgo cardiovascular** | **<140 /< 90 (mmHg).** |
| **Personas de 85 y más años sin Diabetes Mellitus ó Enfermedad Renal Crónica, ó Cardiopatía isquémica o Alto Riesgo Cardiovascular** | **<140/<90 (mmHg).** |

Se debe cumplir durante la consulta con:

- Toma de PA en todas las consultas
- Adecuado estadiaje de la PA:
  Grado 1: 140-159/ 90- 99
  Grado 2 160-179 / 100-109
  Grado 3 180 y mas / 100 y mas

- Anotación de los factores de riesgo:
  Edad: hombres > 55 años y mujeres > 65 años
  Dislipidemia
  Prediabetes
  AHF (IAM Hombres < 55 años y mujeres < 65 años)
  DM
  Tabaquismo
  Obesidad Abdominal
  Presión de pulso en adulto mayor > 70 mmHg
- Daño a órgano blanco:
  Cardiopatía, Nefropatía, Retinopatía, EAP, ECV

- Clasificación y seguimiento según riesgo Factores de Riesgo
  0 factores de riesgo clasificación A
  1 o 2 factores de riesgo clasificación B
  3 o más factores de riesgo o Daño a Órgano Blanco clasificación C
- Anotación del Examen Físico

- Anotación y valoración del Fondo de Ojo o envió de referencia a FO por cámara midriática
- Envió e interpretación de Laboratorios: Hemograma, UN/ Creatinina, relación albumina creatinina, glicemia, perfil lipídico, EGO en cada cita Envío e interpretación del EKG anual

Indicador Complementario:

**Porcentaje de personas de 20 años y más atendidas en el escenario domiciliar por el ATAP con registro de cifras de presión arterial en SIFF. LINEA BASE**

Corresponde al porcentaje de personas de 20 años y más que se les realizó una atención en una visita domiciliar efectiva por los Asistentes Técnicos de Atención Primaria (ATAP), y se les registraron sus cifras de presión arterial (PA), en relación con todas las personas de ese rango de edad atendidas en visita domiciliar, en el periodo.

Visita Domiciliaria Efectiva: Es considerada como tal, cuando el funcionario realiza un mínimo de tres actividades, por familia dependiendo del número de miembros de esta.

Indicador Complementario:

**Porcentaje de personas no conocidas con hipertensión (no HT), tamizadas por el ATAP en el escenario domiciliar**

Corresponde al porcentaje de personas de 20 años y más no conocidas con HT (no HT), a las que se les realiza una visita domiciliar efectiva; por los Asistentes Técnicos de Atención Primaria (ATAP), y se les registran sus cifras de PA en el Sistema Integrado de Ficha

Familiar (SIFF), en relación con la cantidad de personas no conocidas con HT según prevalencia estimada, en el periodo.

Visita Domiciliaria Efectiva: Es considerada como tal, cuando el funcionario realiza un mínimo de tres actividades, por familia dependiendo del número de miembros de esta.

Indicador Complementario:

**Porcentaje de personas de 20 años y más no conocidas con hipertensión, a las que se les registró una presión arterial elevada en la visita domiciliar y fueron referidas por este motivo al EBAIS**

Porcentaje de la población de 20 años y más, sin diagnóstico de hipertensión en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS), a quienes se les detecta cifras elevadas de presión arterial elevadas, por lo que se les refiere para valoración médica oportuna.

Presión arterial elevada: Consiste en el registro de presión sistólica igual o superior a 130 mmHg, o presión diastólica igual o superior a 85 mmHg (puede estar solo una o ambas elevadas).

Referencia: Toda referencia registrada en el sistema de ficha familiar (SIFF) a Sede de EBAIS.

Indicador Complementario:

**Estratificación de riesgo cardiovascular total (RCVT), a las personas con hipertensión. línea Base 33%**

Porcentaje de la población de 20 años y más con hipertensión que consulta, a quienes se les realiza una estratificación del riesgo cardiovascular total con el fin de detectar oportunamente el riesgo de sufrir un evento cardiovascular a 10 años.

Estratificación de riesgo cardiovascular total (RCVT): Consignación, en el espacio destinado para este fin, **en el énfasis de hipertensión**; del nivel de riesgo cardiovascular de la persona con hipertensión según lo establece el protocolo institucional vigente sobre la atención clínica a esta población, en el primer nivel de atención. (Para esta ficha técnica se usa lo indicador en la página 27 del protocolo de atención clínica para la persona adulta y adulta mayor con presión arterial elevada e hipertensión arterial en el primer nivel de atención de la CCSS).

**Página 27.** El procedimiento para realizar el cálculo del riesgo cardiovascular se realiza por medio de una aplicación gratuita (App), basada en las directrices de la OMS-OPS, proporciona una herramienta para estimar el riesgo de enfermedad cardiovascular.

Utiliza las tablas de riesgo de la OMS del 2019 para prever la incidencia a 10 años de eventos cardiovasculares graves a nivel regional, en población de 40 a 75 años (Ver anexo 5).

La aplicación está disponible para computadoras y dispositivos inteligentes a través de los siguientes enlaces

vía Web: https://www.paho.org/cardioapp/web/#/cvrisk
iOS: https://apps.apple.com/us/app/cardiocal/id918099010?ls=1
Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hearts.ops&pcampaignid=web_share

Existen factores de riesgo cardiovascular importantes que no se incluyen en los cálculos habituales, como la obesidad, el sedentarismo, el estrés, enfermedades autoinmunes o antecedentes familiares de enfermedades cardíacas tempranas, entre otros.

Según el riesgo cardiovascular (CCSS, 2015) se puede determinar el riesgo a 10 años con la tabla de predicción de riesgo de la OMS:

✓ Bajo riesgo cardiovascular: estimación de riesgo <5%, se sugiere hacer énfasis en cambios del estilo de vida.

✓ Moderado riesgo cardiovascular: estimación de riesgo del 5% y menor del 10%, se sugiere monitorizar el perfil de riesgo cada 6-12 meses.

✓ Alto riesgo cardiovascular: estimación de riesgo del 10% y menor al 20%, se sugiere monitorizar el perfil de riesgo cada 3-6 meses y el inicio de terapia con estatinas a dosis moderada. En esta categoría se incluyen personas con dislipidemia familiar, HTA severa, DM sin factores de riesgo cardiovascular ni daño a órgano blanco o ERC moderada (TFG 3059mL/min/1.73m2)

✓ Muy alto riesgo cardiovascular: estimación de riesgo del 20% a menos del 30%, se sugiere monitorizar el perfil de riesgo cada 3-6 meses, el inicio de aspirina y estatinas a dosis altas. En esta categoría se incluyen personas con ECV documentada, IAM, síndrome coronario agudo, intervención coronaria percutánea, revascularización coronaria, ictus isquémico, enfermedad arterial periférica, DM con lesión a órgano blanco o ERC grave (TFG <30mL/min/1.73m2).

✓ Riesgo crítico: estimación de riesgo del 30% o más.

Indicador Complementario:

**Tasa de inercia terapéutica en hipertensión para control no óptimo**

La inercia terapéutica en el control de las personas con hipertensión es una condición en la que, a pesar de demostrarse cifras no óptimas de presión arterial en un período determinado, no se realiza ningún ajuste en el tratamiento antihipertensivo-dosis o tipo de medicamento- en al menos cuatro consultas de seguimiento realizadas en ese período.

## ECNT: OBESIDAD Y SÍNDROME METABÓLICO

**A. Porcentaje de personas atendidas de 20 a 64 años con un IMC ≥ 30,0 Kg/m2 a quienes se les registra el diagnóstico de obesidad. Meta: 33%**

Evalúa:
Primera consulta del año con un IMC ≥ 30,0 Kg/m2.
Primera consulta del año con registro del diagnóstico de obesidad.

Excluye: Embarazadas

**B. Porcentaje de personas atendidas de 20 a 64 años con un IMC ≥ 30,0 Kg/m2 y un diagnóstico de obesidad que son referidas a Nutrición. Meta 20%**

Evalúa:
Primera consulta del año con un IMC ≥ 30,0 Kg/m2.

Primera consulta del año con registro del diagnóstico de obesidad. Referencias del periodo a Nutrición.

Excluye:

Embarazadas
Población de 20 a 64 años con IMC ≥30,0 kg/m2 referidos a Nutrición en los cinco periodos anteriores a la evaluación.
.

**C. Porcentaje de personas de 40 a 64 años con obesidad y otro factor de riesgo cardiovascular, que se atienden en consulta modalidad grupal de Nutrición.**

El indicador mide la proporción de personas de 40 a 64 años con obesidad y otro Factor de Riesgo Cardiovascular (FRC) que asisten a la consulta modalidad grupal.

Incluye:

• Atenciones de primera vez de la población de 40 a 64 años con un IMC ≥30,0 Kg/m2 y otro FRC en el periodo.
• Atenciones de las personas de 40 a 64 años con un IMC ≥30,0 kg/m2, otro FRC y registro de participación en la consulta modalidad grupal de Nutrición en el periodo.
• Otro FRC:
- Diabetes Mellitus: Código E11-Diabetes Mellitus tipo 2
- Hipertensión: Código I10X-Hipertensión esencial (Primaria)
- Dislipidemia: Código E78-Trastorno del metabolismo de las lipoproteínas y

Excluye:
Personas atendidas en consulta modalidad grupal de Nutrición en los cinco periodos anteriores a la evaluación
.

D. **Porcentaje de personas de 20 años y más con síndrome metabólico con Atención Multidisciplinaria Completa (AMC) que alcanzan valores normales de triglicéridos.**
**Código Z728 Otros problemas relacionados con el estilo de vida.**

El Síndrome Metabólico (SM) es un trastorno metabólico caracterizado por la presencia de obesidad abdominal y se diagnostica en las personas que presentan tres de los siguientes criterios:

• Circunferencia abdominal elevada:
Mayor o igual a 90 cm en los varones y
Mayor o igual a 80 cm en las mujeres.
• Triglicéridos elevados:
Mayor o igual a 150 mg/dl o con diagnóstico de hipertrigliceridemia.

• HDL colesterol disminuido:
Menor de 40 mg/dl en los varones o personas con tratamiento,
Menor de 50 mg/dl en las mujeres o personas con tratamiento.

• Presión arterial elevada:
Pre-HTA: PA sistólica entre 130-139 mmHg y PA diastólica entre 85- 89 mmHg la diastólica, o
Personas portadoras de hipertensión arterial con tratamiento antihipertensivo (PA mayor o igual a 140/90 mm Hg).

• Glucemia en ayunas: persona prediabética (100 mg/dl a 125 mg/dl)

Atención Multidisciplinaria Completa (AMC): comprende la participación a cinco atenciones de Síndrome Metabólico (SM) registradas en EDUS en modalidad grupal

Triglicéridos normales: es el resultado de la prueba de laboratorio clínico para triglicéridos con valores < 150 mg/dL, disponible a partir de la quinta consulta de la AMC.

Excluye: Personas con SM atendidos en AMC en los cinco años previos al periodo evaluado.

**E. Porcentaje de personas de 20 años y más con síndrome metabólico con Atención Multidisciplinaria Completa (AMC), que logran reducir al menos un 5 % del peso corporal.**

Al menos 5 % de reducción en el peso corporal: corresponde al porcentaje de peso perdido entre el peso de la primera consulta (PPC) y el peso de la quinta consulta (PQC), ambas consultas registradas con el código CIE-10: Z728 Otros problemas relacionados con el estilo de vida.

Excluye: Personas con SM atendidos en AMC en los cinco años previos al periodo evaluado.

**ECNT: CÁNCER:**

Porcentaje bienal de mujeres de 20 a 64 años atendidas a las que se les realizó el tamizaje con citología cervicovaginal.

La frecuencia del tamizaje según grupo de edad y estado de inmunocompetencia es como a continuación:

• 20 a 29 años e inmunocompetentes: se realiza citología convencional o de base líquida cada dos años.

• 30 años o más e inmunocompetentes: se realiza prueba VPH cada cinco años

• 20 a 24 años e inmunocomprometidas: se realiza citología convencional o de base líquida cada dos años

• 25 años y más e inmunocomprometidas: se realiza prueba VPH cada tres años.

Para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) esta intervención se realiza por medio de Papanicolaou o Test de Virus de Papiloma Humano (VPH); este último todavía no se encuentra generalizado para todos los establecimientos quedando pendiente a setiembre 2025 solamente las Redes Integradas de Prestación de Salud Central Norte y Huetar Atlántica

## ENFERMEDAD RENAL CRONICA:

1. **Tamizaje bioquímico para la detección temprana de enfermedad renal crónica (ERC) en población de alto riesgo (HT, DM2).**

Porcentaje de personas atendidas de 20 años y más con HT, DM2 o ambas condiciones, que cuentan con pruebas de laboratorio completas orientadas a la detección de ERC, del total de las personas atendidas con dichos diagnósticos.

Pruebas para detectar ERC: creatinina sérica, relación albuminuria/creatinuria

Pruebas completas:
Cuando presenta resultados de ambas pruebas orientadas a la detección de ERC (creatinina sérica y IAC o, en su defecto, IPC).

Pruebas incompletas:
Cuando no presenta resultado de una o ninguna de las pruebas.

Excluye: Población de 20 años y más con diagnóstico de ERC (CIE-10: N18.0–N18.9), en el año anterior.

Indicador Complementario: Porcentaje de personas de alto riesgo (HT, DM2) que reciben solo creatinina sérica sin determinación de albuminuria o proteinuria

2. **Porcentaje de personas de alto riesgo (HT, DM2) con alteración renal inicial que cuentan con la confirmación de cronicidad.**

Porcentaje de personas atendidas de 20 años y más con HT, DM2 o ambas condiciones, que, tras presentar sospecha de ERC, reciben una prueba de seguimiento oportuno dentro del intervalo de tiempo establecido para confirmar o descartar cronicidad.

Sospecha de Enfermedad Renal Crónica: presencia de al menos una determinación de la TFGe <60 ml/min/1.73 m², calculada mediante la ecuación CKD-EPI 2021 (sin ajuste racial), o una medición de albuminuria (RAC ≥30 mg/g) o proteinuria (IPC ≥150 mg/g), o alteraciones del sedimento urinario, histológicas o en pruebas de imagen.

Prueba de seguimiento oportuno:
Realización de una prueba de creatinina sérica, IAC o IPC, entre los 90 y 119 días, ya sea previa o posterior al resultado inicial alterado.

Indicador complementario:

**Porcentaje de personas de alto riesgo con alteración renal inicial sin seguimiento oportuno para confirmar cronicidad.**

Categorías de seguimiento:

- Ausencia: No se realizó seguimiento para confirmar cronicidad.
- Tardío: El seguimiento se realizó fuera del tiempo recomendado (≥120 días).
- Prematuro: El seguimiento se realizó antes del tiempo recomendado (<90 días)

3. **Porcentaje de personas con sospecha de Enfermedad Renal Crónica no tradicional (ERCnt) que cuentan con la confirmación de cronicidad.**

La Sospecha de Enfermedad Renal Crónica no tradicional: se define como todo paciente de 10 a 60 años con TFGe <60 ml/min/1.73 m² en una determinación o daño funcional, o estructura renal como lo es la microalbuminuria (RAC ≥30 mg/g) o proteinuria (IPC ≥150 mg/g), alteraciones del sedimento urinario, o en estudios por imágenes, sin la presencia de antecedente de diagnóstico de enfermedad con reconocida asociación con la presencia de ERC (Diabetes, hipertensión, lupus, nefropatía hereditaria, enfermedad autoinmune, uropatía obstructiva, cardiopatía hipertensiva, nefropatía crónica hipertensiva, cardiopatía y nefropatía crónica hipertensiva, malformaciones congénitas, poliquistosis renal, anemia drepanocítica, vasculitis y mieloma), ni presencia de lesión renal aguda o Enfermedad Renal Aguda, demostrada al momento del diagnóstico.

Prueba de seguimiento oportuno:
Realización de una prueba de creatinina sérica, IAC o IPC, entre los 90 y 119 días, ya

sea previa o posterior al resultado inicial alterado.

Indicador complementario:

**Porcentaje de personas con sospecha de ERCnt sin seguimiento oportuno para confirmar cronicidad.**

Categorías de seguimiento:

- Ausencia: No se realizó seguimiento para confirmar cronicidad.
- Tardío: El seguimiento se realizó fuera del tiempo recomendado (≥120 días).
- Prematuro: El seguimiento se realizó antes del tiempo recomendado (<90 días)

## CRITERIOS DE REFERENCIA PARA NUTRICIÓN:

1. Edad
2. Motivo de la referencia, indicando el/ los diagnósticos por los que se refiere, no omitir ningún diagnóstico médico relacionado con la atención nutricional para poder clasificar la atención de la mejor manera
3. Laboratorios: glicemia en ayunas, hemoglobina glicosilada en DM, triglicéridos, HDL, colesterol total, colesterol LDL.
4. Medidas antropométricas: peso, talla, IMC y Circunferencia abdominal.
5. Tratamiento y recomendaciones brindadas.
6. Se Refieren solo obesidad grado 2 y 3, y grado 1 solo en casos excepcionales.

Recordar preguntar al usuario si desea la atención nutricional, de lo contrario, evitar realizar la referencia para así, evitar posibles ausentes y dar el espacio a quienes realmente estén interesados y requieran llevar el proceso nutricional correspondiente

## CRITERIOS DE REFERENCIA PARA ATENFAR:

Paciente motivado y con disponibilidad de seguimiento en citas. En la referencia vamos a indicar paciente NOVAPLAN

a. Médico confirma que paciente acepta ir a citas.
b. Interés en modificar estilos de vida.

Hipertensión de riesgo elevado:

a. PA mayor o igual a 160/100 repetida en las 2 ultimas consultas
b. Uso de 3 antihipertensivos o más.

Diabetes Mellitus 2 HB glicosilada mayor o igual a 9 con al menos 2 criterios adicionales.

a. Variabilidad glicémica alta.
b. Neuropatía incipiente.
c. Dificultad documentada para ajustes de insulina.
d. Microalbuminuria positiva

e. Historia de Hipoglicemia severa.
f. Descompensación reciente o súbita mayor o igual a 2 % en los últimos 6 meses.

Pacientes con polifarmacia o tratamientos complejos.
a. Cambios frecuentes en dosis.
b. Interacciones potenciales.
c. Confusión constante con su tratamiento.

## CRITERIOS DE REFERENCIA PARA OPTOMETRÍA:

**No se deben referir:**

- Pacientes asintomáticos ya que las correcciones Optométricas se dan solamente si se presentan síntomas relacionados con las molestias.
- Pacientes que solo quieran “saber cómo están de la vista”
- Pacientes que solo quieran ser valorados por oftalmología por presentar pterigión o catarata.
- Pacientes con menos de 1 año de haber sido valorados por optometría.
- Pacientes con cataratas muy avanzadas que limiten su AV ya no mejoran con lentes.
- Niños menores de 4 años ya que en primer nivel de atención no se realiza examen bajo cicloplejia.

**Se pueden referir**

- Astenopias (Fatiga Visual)
- Cefaleas
- Disminución de agudeza visual
- Pacientes usuarios de lentes con más de 1 año del último control
- Pacientes con lentes deteriorados.
- Niños que se acerquen mucho a la lectura.
- Pterigiones que no sobrepasen la pupila.

Atentamente,

**DIRECCIÓN MEDICA**

NURIA YANORI MARIN MONGE (FIRMA)
Firmado digitalmente por NURIA YANORI MARIN MONGE (FIRMA)
Fecha: 2025.12.09 18:36:26 -06'00'

Marin Monge Nuria
**Directora Medica**
**Area de Salud de Guapiles**

Cc:
Archivo